

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	小量灌腸技術 Small Amount Enema				
編號	A31000-Q05-W-A29	制定者	N09 陳美如	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 4.1 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能正確操作小量灌腸技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

- 1.軟化糞便，使糞便易於排出。
- 2.驅氣作用，可減輕腹脹。
- 3.給藥作用（鎮靜、排除氮值）。

（二）用物準備

- 1.治療盤一個、看護墊或防漏中單 1 條、衛生紙（數張）、Jelly1 包、便盆一個、清潔手套一雙。
- 2.灌食空針、肛管或拋棄式小量灌腸器。
- 3.治療碗 1 個（依醫囑配置灌腸溶液）。
- 4.溶液：
 - (1)拋棄式小量灌腸器。
 - (2)依醫囑配置灌腸溶液，例如：鎮靜、排除氮值之藥物。

主題名稱	小量灌腸技術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A29	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	2/7

(三) 步驟及要點說明

步驟	說明
1. 核對電腦 HIS 護理系統，於護理執行核對預定醫囑，並於核對狀態核簽“正確”。	
2. 正確使用兩種以上辨識方法辨識病人，向病人解釋目的及過程，詢問是否需要便盆或床邊便盆椅。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
3. 工作前洗手。	
4. 準備用物：	
(1)治療盤一個、看護墊或防漏中單一條、衛生紙（數張）、潤滑液、便盆一個、清潔手套一副。	
(2)灌食空針、肛管或拋棄式小量灌腸器。	視需要選擇適當之肛管： 成人：18～22Fr；小孩：14～18Fr.
(3)治療碗一個（依醫囑配置灌腸溶液）。	依醫囑配置灌腸溶液，以手前臂內側測試溫度以不燙手為準，溫度太高會傷及腸黏膜或可能引起昏厥，太低則可能使肛門肌肉收縮痙攣。
(4)溶液：	
A.拋棄式小量灌腸器。	
B.依醫囑配置灌腸溶液例如：鎮靜、排除氨值之藥物。	
5. 準備病人：	
(1)進行病人辨識，再次核對病人。	
(2)將用物攜至病人單位，圍布簾關窗簾。	注意病人隱私，於床簾外夾”治療中請勿打擾”小牌。
(3)協助病人將褲子脫至膝處，並採左側臥，且使臀部靠近床邊予以適當暴露，適當覆蓋病人。	依照生理解剖位置，降結腸位於身體左側，左側臥可藉由重力助灌腸溶液流入結腸中。
(4)將防漏中單或看護墊，墊於病人臀下。	
6.執行灌腸：	
(1)戴上手套，以 jelly 潤滑肛管前端約 5~10 公分。	注意勿使潤滑液塞住肛管頭。
(2)使用拋棄式小量灌腸器，先將蓋子移除，予排氣後灌入；如使用醫囑配置灌腸溶液，可先使用灌食空針抽取溶液後再接至肛管，進行排氣後灌入；若使用倒入方式，先將灌食空針接於肛管，	預防空氣流入而引起腹脹不適。

主題名稱	小量灌腸技術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A29	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
用一手控制肛管同時把它反折，避免空氣進入，另一手倒一部份溶液於灌腸空針內，排出少量溶液，再將肛管反折，避免空氣進入。	
(3)請病人微張口或講“啊”或與病人談話。	分散病人注意力，以助病人放鬆腹肌。
(4)手持衛生紙，輕輕撥開肛門區的肌肉露出肛門口，另一手將肛管輕輕插入肛門放鬆肛管，讓液體緩緩流入。	插入深度：成人：7.5～10 公分；兒童：5～7.5 公分；嬰兒：2.5～3.75 公分。
(5)告知病人若覺腹部疼痛或想解便時，需告知護理人員（可減低流速或暫停），隨時觀察病人反應。	若流速太快，會刺激結腸引起排便反應，無法達到效果。
(6)若使用小量灌腸器，以非慣用手持衛生紙壓住肛門口，灌腸液流盡，仍須緊壓小量灌腸器瓶底、勿放鬆，以免將擠出的溶液又吸回瓶內，然後輕抽出。	
(7)抽出肛管，以手套或衛生紙包住肛管頭，自灌腸空針取下肛管棄置於感染性垃圾桶內。	
(8)囑病人儘量忍住便意 5-10 分鐘，使糞便有足夠的時間軟化。	可用衛生紙壓住肛門，防止液體外流。
(9)病人無法再保留灌腸液時，立刻協助解便。	置衛生紙及呼叫鈴於病人易取得處，予病人充足時間解便，留意病人是否為跌倒高危險群採取相關防護措施。
7.灌腸後之處理：	
(1)待病人解便後，移去便盆，並觀察排泄物性質，如需檢驗則先留標本後再倒掉。	
(2)協助病人清潔並穿好衣褲。	
(3)移去防漏中單或看護墊。	
(4)整理病人單位及用物。	
(5)攜出之各用物，依醫院規定垃圾分類處理。	
(6)洗手。	
(7)核對電腦 HIS 護理系統於執行狀態核簽“正確”。	護理記錄內容應包括：灌腸時間、使用溶液、灌入量、排泄物的性質、顏色、病人反應，視需要於資訊系統紀錄排出量。

（四）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	小量灌腸技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A29	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	4/7

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 陳淑齡 (2023)．排泄需要．於蘇麗智等編著，實用基本護理學下冊（九版，375-430 頁）．台北市：華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	小量灌腸技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A29	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	5/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定	89 年 01 月 31 日 通過護理部技術標準委員會。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.06.01	2.1	新增說明：因降結腸位於身體左側，左側臥可藉著重力助灌腸溶液流入結腸中	100 年 06 月 01 日 通過護理部技術標準委員會。
101.04.11	2.2	新增步驟修辭：使大便有足夠的時間軟化	101 年 04 月 11 日 通過護理部技術標準委員會。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.04.03	3.1	說明(三)步驟及要點說明部份修辭 步驟 7.灌腸後之處理(7)說明刪除：若為有效灌腸，則於體溫單上的大便記錄欄內記錄 1/E，若無效則記錄 0/E」。	102 年 04 月 03 日 通過護理部技術標準委員會。
103.03.18	3.2	步驟 6.(6)增加說明：以手套或衛生紙包住肛管頭，自灌腸空針取下肛管棄置於感染性垃圾桶內	103 年 03 月 18 日 通過護理部技術標準委員會。
104.03.17	3.3	1. 新增第三項第(三)目之 2 說明內容。 2. 更新第六項參考資料及版本。	104 年 03 月 17 日 護理部技術標準委員會通過
105.03.15	3.4	1. 病人辨識新增、詢問病人需求加入便盆椅選項。 2. 步驟第 3 點，現暫無使用溫度計測量水溫，以手背測試溫度已不燙手為準。 3. 更新第六項參考資料。	105 年 03 月 15 日 護理部技術標準委員會通過
106.03.14	3.5	第三項說明刪除：灌腸空針，皆改為灌食空針。	106 年 03 月 14 日 護理部技術標準委員會通過
107.05.09	3.6	第三項第三目步驟及要點說明內容修訂。	107 年 05 月 09 日 護理長會議通過

主題名稱	小量灌腸技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A29	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	6/7

108.03.18	3.7	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項說明用物準備項目進行增修。 3. 第三項第三目步驟及要點說明內容修訂。 4. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 03 月 18 日 護理技術組會議通過；108 年 04 月 10 日 護理長會議通過；108 年 04 月 23 日 督導會議通過公布。
109.04.21	3.8	第三項第三目步驟及要點說明內容修辭修訂。	109 年 03 月 16 日 護理技術組會議通過；109 年 04 月 08 日 護理長會議通過；109 年 04 月 21 日 督導會議通過公布。
110.03.15	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.05.03	3.9	1. 第三項說明用物準備項目刪除甘油球。 2. 第三項第三目步驟及要點說明內容刪除甘油球。	111 年 03 月 21 日 護理技術組會議通過；111 年 04 月 13 日 護理長會議通過；111 年 05 月 03 日 督導會議通過公布。
112.03.20	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.16	4.0	1. 第三項第二目用物準備刪除凡士林。 2. 第三項第三目步驟及要點說明刪除凡士林。	113 年 03 月 18 日 護理技術組會議通過；113 年 04 月 10 日 護理長會議通過；113 年 04 月 16 日 督導會議通過公布。
114.03.17	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	4.1	1.主題修正為技術 2.第六項參考資料更新	115 年 03 月 16 日 護理技術組會議通過；115 年 03 月 18 日

主題名稱	小量灌腸技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A29	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	7/7

			日護理長會議通過；115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。
--	--	--	-----------------------------------